

Le monotropisme et sa toile de comorbidité : liens directs et indirects aux conditions comportementales, psychiatriques et neurodéveloppementales

Un brief de recherche cité.

Synthèse

Le **monotropisme** (Murray, Lawson & Lesser, 2005) est une théorie de l'attention autistique qui cadre l'autisme comme une différence d'*allocation des ressources* : un esprit monotrope concentre les ressources de traitement dans un petit nombre de « tunnels d'attention » hautement activés, laissant moins de ressources pour les canaux périphériques. Une mesure d'auto-évaluation de 2023 — le **Monotropism Questionnaire (MQ)** — fournit la première validation empirique, montrant que les personnes autistes et TDAH obtiennent des scores significativement plus élevés que les contrôles non-autistes/non-TDAH [1][2][3]. Un modèle évalué par les pairs étroitement apparenté, le compte de l'**allocation atypique des ressources** de Goldknopf, argue que la même attention rétrécie-intense peut lier les caractéristiques sensorielles, sociales, exécutives et motrices de l'autisme — tout en avertissant que c'est « très probablement un facteur chez les autistes avec de forts symptômes sensoriels », pas la cause unique [4].

Parce que le monotropisme est une théorie de *la façon dont les ressources sont dépensées*, il ondule vraisemblablement dans de nombreux domaines. Le tableau honnête, cependant, se divise en trois niveaux :

- **Niveau 1 — Liens directs, empiriquement soutenus.** Le recoupement autisme–TDAH (« AuDHD ») est le plus fort : le MQ montre que l'attention monotrope est élevée dans *les deux* conditions, recadrant la « scission monotrope » (tunnels concurrents ou instables) comme un phénotype attentionnel réel, mesurable [2][3][5]. Les recoupements au niveau mécanisme — l'**interoception** atypique et la **dysfonction exécutive** — sont bien documentés et aident à expliquer les problèmes en aval d'alimentation, d'encombrement et d'évitement [6][7][8].
- **Niveau 2 — Comorbidité indirecte, à mécanisme partagé.** L'autisme recoupe notablement l'**anorexie/alimentation restrictive** et le **TOC**. Dans chaque cas la comorbidité est réelle et répliquée, mais le pont *le mieux documenté* est un mécanisme partagé (interoception ; traitement ego-syntone vs ego-dystone) plutôt que le monotropisme spécifiquement [6][9][10].
- **Niveau 3 — Extrapolation plausible ou construits contestés.** Certains liens du cadre populaire — les « tas de fatalité » (doom piles) comme une défaillance de permanence de l'objet monotrope, l'agoraphobie comme résultat monotrope primaire, la **PDA** comme profil distinct — reposent sur une évidence plus faible ou contestée et devraient être traités comme des hypothèses, pas des faits établis [11][12][13].

Tout au long, un thème récurrent : de nombreux comportements qui ressemblent à des « troubles » séparés se lisent mieux comme **le coût cognitif d'un système d'attention étroit en collision avec un monde polytrope** — mais seules certaines de ces lectures ont été testées directement.

1. Fondations : ce qu'est le monotropisme, et sa solidité

Le monotropisme propose que les esprits diffèrent dans la façon dont ils distribuent les ressources attentionnelles. Un esprit **polytrope** garde de nombreux canaux d'intérêt actifs à la fois (large, peu profond, bascule facile) ; un esprit **monotrope** canalise les ressources dans quelques « tunnels d'attention » intensément activés (étroit, profond, dur à basculer) [1][3]. Les créateurs — Dinah Murray, Wenn Lawson et Mike Lesser — ont d'abord présenté l'idée aux conférences Durham sur l'autisme à

partir de 1992 et l'ont formalisée en 2005, arguant qu'elle explique les traits autistiques (intérêts spéciaux, besoin d'identité, détresse aux transitions, focus sur le détail) mieux que les modèles uniquement déficitaires [1][14].

Son statut scientifique a changé ces dernières années :

- Il est **empiriquement mesurable**. Le MQ (Garau et al., 2023) est un instrument d'auto-évaluation à 47 items testé sur 1 110 participants (756 autistes, 354 non-autistes). Les participants autistes et TDAH ont obtenu des scores significativement plus élevés que les contrôles [2][3].
- Il a un **cousin mécanistique évalué par les pairs**. Le modèle d'« allocation atypique des ressources » de Goldknopf (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) opérationnalise l'intuition : dans l'autisme, les ressources attentionnelles sont **rétrécies** (vers moins/plus petites zones, modalités et étapes de traitement, parfois plus intensément) et/ou **réduites** en capacité globale — un cadre qui lie explicitement langage, cognition sociale, atypicalité sensorielle/attentionnelle et différences exécutives/motrices [4].
- Il se situe **à côté, non au lieu**, d'autres théories cognitives (théorie de l'esprit ; cohérence centrale faible / style centré sur le détail (Happé & Frith, 2006) ; dysfonction exécutive) [4][15].
- C'est encore un **modèle, pas un biomarqueur**. Goldknopf est explicite que c'est un facteur parmi plusieurs, « très probablement » saillant chez les autistes avec de forts symptômes sensoriels [4]. Murray et collègues cadrent pareillement le monotropisme comme une *lentille* unificatrice, pas une étiologie complète [1][14].

Implication pour le reste de ce brief : le monotropisme est une idée organisatrice crédible, de plus en plus validée, mais sa *portée explicative* dans chaque comorbidité doit être argumentée cas par cas — non présumée.

2. Niveau 1 — Liens directs : le cluster neurodéveloppemental

2.1 AuDHD et la « scission monotrope » (*lien direct le plus fort*)

L'autisme et le TDAH co-occurrent bien plus souvent que le hasard ne le prédirait : le TDAH est présent chez environ **30–80 %** des autistes, et l'autisme chez environ **20–50 %** de ceux avec TDAH [5] ; une méta-analyse situe les taux de symptômes ASD dans les échantillons TDAH autour de **21 %** [16] ; une grande étude Medicaid a trouvé que **27 %** des adultes autistes sans déficience intellectuelle avaient un diagnostic TDAH co-occurrent — environ 10× le taux général [17]. Le recoupement est substantiellement génétique (~50–72 %) [18].

Le monotropisme aide à résoudre une vieille énigme : si l'autisme est « hyper-focus » et le TDAH « inattention », pourquoi co-occurrent-ils ? Le MQ répond empiriquement — **les personnes TDAH, surtout AuDHD, sont aussi hautement monotropes** [2][3]. L'hyperfocale dans le TDAH (Grotewiel et al., 2022) est conceptuellement quasi identique au tunnel monotrope [19]. Le cadre de la « scission monotrope » refaçonne donc AuDHD non comme des opposés mais comme **un système instable de tunnels d'attention concurrents ou à bascule rapide** : le cerveau exige un focus monotrope profond mais ne peut pas stabiliser le tunnel, produisant l'oscillation AuDHD familière entre engagement intense, burnout rapide et sous-stimulation chronique [19][20].

Réserve : le mécanisme des « tunnels concurrents multiples » est *plausible et cohérent avec les données MQ* mais pas encore directement testé comme dynamique ; il se lit comme une hypothèse forte.

2.2 Burnout autistique et rupture de tunnel

Le burnout autistique — épuisement chronique, perte de compétences et tolérance réduite — est de plus en plus lié au coût cumulé de la bascule de tunnel constante, du masquage et des exigences dépassant les capacités, avec un temps insuffisant de récupération/flux [20][21]. C'est un domaine où le monotropisme est heuristiquement puissant (chaque transition forcée est une rupture de tunnel), bien que la littérature du burnout elle-même soit encore en maturation et que le chemin monotropisme→burnout soit largement clinique/à la première personne plutôt qu'établi expérimentalement [20].

2.3 Évitement de la demande et PDA (*construit contesté*)

Une demande — « prépare-toi », « fais ce formulaire » — peut être vécue comme une intrusion violente dans un état de flux. C'est le compte monotrope intuitif de **l'évitement de la demande**. Le construit plus spécifique **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, forgé par Elizabeth Newson dans les années 1980 et désormais souvent recadré comme « Pervasive Drive for Autonomy », décrit un besoin de contrôle et d'évitement des demandes ordinaires piloté par l'anxiété [11][22].

Deux choses doivent être séparées :

- **Le comportement d'évitement de la demande est réel et courant** dans l'autisme, et le compte monotrope de « rupture de tunnel » est une *histoire mécanistique* raisonnable pour la panique et la résistance qu'il produit.
- **La PDA comme *profil ou sous-type distinct* n'est pas établie.** La National Autistic Society du Royaume-Uni déclare « aucune recherche n'a trouvé de forte évidence pour [la PDA] comme profil distinct » [11] ; l'étude fondatrice de Newson a été critiquée pour **raisonnement circulaire et sur-interprétation** (des groupes définis par les chercheurs étaient ensuite « étudiés ») [12][13] ; et des revues notent des problèmes persistants de définition, de validité du construit et de mesure [23]. Une revue de 2023 s'intitule pointûment « *Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion* » [13].

Ainsi le cadre du texte source est à moitié juste : l'*expérience* (une demande brise le tunnel) est bien décrite par le monotropisme ; l'*entité diagnostique* (PDA) est contestée et ne devrait pas être présentée comme réglée.

3. Niveau 2 — Comorbidité indirecte, à mécanisme partagé

3.1 Anorexie et alimentation restrictive

Le recoupement autisme–anorexie est robuste et bidirectionnel : environ **20–30 %** des patients avec troubles du comportement alimentaire montrent des traits autistes cliniquement significatifs, avec les taux les

plus élevés dans l'anorexie mentale et l'ARFID [6][24] ; inversement, les adultes autistes ont des taux élevés de troubles alimentaires.

Crucialement, les traits autistes sont observés **avant** l'apparition du TCA, donc le recoupement n'est pas simplement un effet de la famine [6].

Le pont *mécanistique* le mieux documenté est **l'interoception** — la perception des signaux corporels internes (battement cardiaque, satiété). Une interoception atypique est impliquée dans l'étiologie *à la fois* de l'autisme et des troubles alimentaires et « peut, au moins en partie, être responsable » de leur comorbidité [6]. La même atypicalité interoceptive sous-tend **l'alexithymie** (difficulté à identifier/verbaliser les émotions), présente chez ~50 % des autistes et elle-même liée à la pathologie alimentaire [7][8].

Où le monotropisme s'inscrit (et ne s'inscrit pas) : il est raisonnable de dire qu'une personne monotrope profondément dans un tunnel peut *manquer* les signaux de faim — mais l'affirmation spécifique du texte source selon laquelle « le monotropisme réduit l'interoception » surestime la chaîne causale. La relation documentée est **autisme** → **interoception/alexithymie atypiques** → **vulnérabilité alimentaire** ; le monotropisme est une caractéristique parallèle de l'autisme, pas la *cause* démontrée de la différence interoceptive [6][7]. Le suivi alimentaire/calorique peut aussi devenir un tunnel à part entière, mais c'est plausible-mécanisme plutôt que testé.

3.2 TOC vs hyper-focus : une distinction authentique

L'autisme et le TOC co-occurrent substantiellement : ~**17 %** des autistes remplissent les critères de TOC, versus ~1–2 % dans la population générale [9]. Malgré une similarité de surface (comportement répétitif, rigidité), le **moteur affectif diffère** et c'est bien établi cliniquement :

- Les intérêts restreints/répétitifs **autistiques** sont typiquement **ego-syntones** — agréables, apaisants, pilotés par l'intérêt, souvent régulateurs.
- Les compulsions du **TOC** sont **ego-dystones** — non voulues, pilotées par l'anxiété, accomplies pour neutraliser les résultats redoutés [9][10].

La distinction du texte source est donc correcte et étayée par les données, et est confirmée directement par les participants autistes eux-mêmes : dans une étude qualitative ils ont rapporté que les

comportements répétitifs sont « une partie de qui ils sont », tandis que les symptômes du TOC « confltent avec la façon dont ils se voient » [10]. La même étude cadre pertinemment la co-occurrence comme « *Autism is the arena and OCD is the lion* » — les symptômes du TOC peuvent « détourner » les intérêts spéciaux autistiques, gonflant leur intensité et leur détresse [10]. Le monotropisme ajoute du contexte (un tunnel peut être *capturé* par le contenu du TOC) mais la différenciation repose sur l'axe ego-syntone/dystone, non sur le monotropisme per se.

3.3 Anxiété et troubles affectifs (le substrat sous « l'agoraphobie »)

L'anxiété est parmi les comorbidités de l'autisme les plus courantes (une revue secondaire cite ≥ 1 comorbidité psychiatrique chez ~86 % des autistes) [25]. Deux points de mécanisme importent pour le cluster comportemental ci-dessous : (i) l'**hyper-réactivité sensorielle** et l'anxiété sont liées, et à travers le *conditionnement de contexte* produisent l'**évitement comportemental de lieux généralisés** (restaurants, magasins, fêtes) [26] ; (ii) la co-occurrence fréquente de l'alexithymie/difficulté interoceptive signifie que les états émotionnels sont souvent mal étiquetés, alimentant une anxiété diffuse [7].

4. Niveau 3 — Cluster comportemental/fonctionnel : encombrement, accumulation, évitement, retrait social

4.1 Encombrement, « tas de fatalité », et dysfonction exécutive

Le *phénomène* est bien soutenu : les autistes et TDAH montrent des taux élevés de désorganisation et d'encombrement, et la voie la mieux documentée est la **dysfonction exécutive** — déficits de catégorisation, prise de décision, planification et mémoire de travail [8][27]. Les symptômes d'accumulation sont élevés à la fois dans le TDAH (avec un « lien spécial avec l'inattention » [8a]) et l'autisme [8] ; dans l'autisme spécifiquement, un travail qualitatif montre que la difficulté à jeter est liée aux **attachements d'intérêt et de sens**, pas simplement à la valeur d'objet [28].

Réserve sur le texte source : l'affirmation spécifique que l'encombrement persiste à cause d'un « **déficit de permanence de l'objet** » autistique (« hors de vue, hors de l'esprit ») n'est **pas soutenue par une évidence évaluée par les pairs** que j'ai pu localiser. La

permanence de l'objet est typiquement *intacte ou supérieure* dans l'autisme ; l'expérience « hors de vue, hors de l'esprit » se lit mieux comme un effet de **mémoire de travail/allocation de l'attention** (un esprit tunnelisé ne se réoriente pas vers les objets stockés) qu'une défaillance de permanence de l'objet perceptuelle. Le mécanisme documenté pour l'encombrement reste **dysfonction exécutive plus attachement d'intérêt**, qui recoupe la population monotrope/AuDHD mais n'est pas uniquement « monotrope » [4][8][28].

4.2 Comportement du spectre de l'accumulation

Le trouble d'accumulation touche ~1,5–6 % de la population générale mais est élevé dans l'autisme [29]. Chez les adultes autistes, la difficulté de type accumulation à jeter est fréquemment rapportée aux côtés de **difficultés cognitives (exécutives) et de forts attachements d'intérêt/sens** — les objets sont des nœuds dans une toile d'idées et d'utilité future, donc jeter semble perte [28]. C'est cohérent avec un *style* monotrope (traitement profond des objets) mais, encore, le moteur documenté est FE/attachement, partagé à travers les conditions neurodéveloppementales [8].

4.3 Agoraphobie et bornage de « l'espace sûr » (à corriger)

Le texte source cadre le confinement à domicile agoraphobique comme un résultat monotrope quasi direct. Les données sont plus nuancées :

- L'agoraphobie est élevée dans l'autisme — ~**23–25 %** des adultes autistes (sans déficience intellectuelle) vs ~1,3 % dans la population générale — **mais elle est moins courante que la phobie sociale ou le TAG**, et l'effet se concentre chez ceux sans DI [25].
- Le moteur le mieux documenté est **l'hyper-réactivité sensorielle + l'anxiété sociale**, avec l'évitement conditionné en contexte des lieux écrasants — c.-à-d. le comportement d'« espace sûr » est réel mais est **secondaire à l'anxiété sensorielle/sociale**, pas un phénomène monotrope primaire [25][26].

Donc : le monotropisme aide à expliquer *pourquoi* le monde extérieur semble perturbateur (imprévisible, polytrope, brise-tunnel), mais classer le confinement résultant comme « agoraphobie » spécifique au monotropisme surestime le lien. C'est un évitement piloté par l'anxiété sensorielle qui *recoupe* l'expérience monotrope.

4.4 Retrait social, le « info-dumping », et le problème de la double empathie

L'interaction sociale est authentiquement polytrope — elle exige le suivi simultané des visages, du ton, de la hiérarchie, du timing et des règles non écrites — elle est donc disproportionnellement coûteuse pour un système monotrope, un point cohérent avec le modèle de ressources de Goldknopf [4]. L'intuition du texte source est fondée.

Mais le cadre plus pointu, *empiriquement soutenu*, pour la rupture de communication qui en résulte est le **problème de la double empathie** (Milton, 2012 ; 2017) : la difficulté est *bidirectionnelle* et relationnelle — une « disjonction dans la réciprocité entre deux acteurs sociaux différemment disposés » — pas un déficit d'empathie unidirectionnel chez la personne autiste [30]. Un travail empirique montre désormais que les observateurs non-autistes *détectent et démontrent* tous les deux le problème de la double empathie dans les interactions mixtes [31]. Le « info-dumping » s'insère naturellement : c'est une communication qui cherche la profondeur d'un système monotrope, qui échoue quand le partenaire ne peut pas égaler la profondeur — une inadéquation de styles de traitement, pas un manque d'empathie [30][31].

Lacune à signaler : la littérature DEP exclut encore largement les enfants autistes, les personnes non-verbales et les personnes avec déficience intellectuelle, donc la généralisation est limitée [32].

5. La frontière : où le compte monotrope va trop loin

Affirmation dans le cadre source/laïc	Statut des données	Meilleur cadre
Le monotropisme cause les caractéristiques de l'autisme	Partiellement soutenu (MQ ; Goldknopf)	Un facteur organisateur validé parmi plusieurs ; le plus fort dans l'autisme avec sensoriel [1][4]

Affirmation dans le cadre source/laïc	Statut des données	Meilleur cadre
AuDHD = « scission monotrope » (tunnels concurrents)	Fort + directement mesurable (MQ)	Un vrai phénotype attentionnel ; le mécanisme dynamique est de niveau hypothèse [2][3]
La PDA est un profil autistique distinct	Contesté	L'évitement de la demande est réel ; la PDA-comme-entité manque de validité du construit [11][12][13]
Le monotropisme réduit l'interoception → anorexie	Indirect	Le pont est autisme→interoception/alexithymie→vulnérabilité TCA ; le monotropisme est parallèle, pas la cause montrée [6][7]
Encombrement par un « déficit de permanence de l'objet »	Non soutenu	Dysfonction exécutive + attachement d'intérêt ; pas de déficit perceptuel de permanence d'objet documenté [4][8][28]
L'agoraphobie comme résultat monotrope primaire	Exagéré	Secondaire à l'hyper-réactivité sensorielle + anxiété sociale ; moins courant que TAG/phobie sociale [25][26]
Le TOC vs les « obsessions » monotropes diffèrent par l'affect	Bien soutenu	Ego-dystone (TOC) vs ego-syntone (intérêt autistique) ; le TOC peut « détourner » les tunnels [9][10]
Le problème de la double empathie explique la rupture sociale	Soutenu (mais lacunes)	Inadéquation bidirectionnelle ; échantillons biaisés vers adultes verbaux sans DI [30][31][32]

6. Questions ouvertes

1. **Test dynamique du tunnel.** Le MQ est une mesure de *trait*. La « scission monotrope » (tunnels concurrents/instables dans AuDHD) est-elle observable en attention/EEG en temps réel ? Largement non testé.
2. **Flèche causale vers l'interoception.** Une distribution de ressources monotropes *produit*-elle une atypicalité interoceptive, ou partagent-elles une cause amont commune ? Les données actuelles ne peuvent pas séparer ces options [6][7].
3. **Résolution PDA.** La recherche sur l'évitement de la demande convergera-t-elle vers un construit validé, mesurable, ou restera-t-elle une catégorie laïc/clinique contestée ? [11][13]
4. **Mécanisme de l'encombrement.** Le « hors de vue, hors de l'esprit » est-il un effet de mémoire de travail/allocation (plausible) ou autre chose ? Aucune étude dédiée trouvée.
5. **Généralisabilité DEP.** Comment le problème de la double empathie opère-t-il pour les personnes autistes non-verbales, les enfants et les personnes avec déficience intellectuelle co-occurrence ? [32]
6. **Burnout.** Quelle est la contribution spécifique, testable, de la rupture de tunnel monotrope au burnout autistique versus le masquage, le traumatisme et la demande chronique ? [20]

Sources

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (préprint). Commentaire/résumé :
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; miroir : <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — résumé des données MQ (47 items ; N=1 110 ; autistes + TDAH obtiennent des scores significativement plus élevés) :
<https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation

may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — revue de comorbidité TDAH et autisme (TDAH chez ~30–80 % d'ASD ; ASD chez ~20–50 % de TDAH ; cite Lau-Zhu 2019 ; Hollingdale 2019) :

<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsy.2025.1573263) — ~50 % des autistes ont l'alexithymie, médiée par des déficits interoceptifs.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] le « lien spécial avec l'inattention » est le propre sous-titre du papier. Voir aussi Drake Institute sur TDAH/dysfonction exécutive :

<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — résumé de revue systématique : ~17 % des autistes remplissent les critères de TOC vs ~1–2 % population générale ; distinction ego-syntone vs ego-dystone :

<https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitatif). PMC11497754.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance (« aucune recherche n'a trouvé de forte évidence pour [la PDA] comme profil distinct ») :

<https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA

— critique du raisonnement circulaire de Newson (Green et al. 2018 ; O'Nions & Eaton 2020) :

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.202>

4.1230011/full [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (cité via étude comparative Frontiers 2024) : <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (cité via Psych Scene Hub et Autistica) : <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27 % des adultes autistes sans DI avaient un TDAH co-occurent (~10× population générale) : <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — résumé du recoupement génétique (~50–72 %) : <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-audhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD comme tunnels concurrents ; références Grotewiel et al. 2022 sur l'hyperfocale TDAH) : <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (états de flux ; références Heasman et al. 2024 "autistic flow theory") : <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, 1980s ; recadrage "Pervasive Drive for Autonomy") : <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (cite aussi Westwood, Mandy & Tchanturia 2017 ; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agoraphobie dans l'autisme ~23–25 % (sans DI) vs

~1,3 % population générale ; moins courante que phobie sociale/TAG (source secondaire, s'appuie sur Helles et al. 2020 et Lugnegård et al. 2012) : <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — conditionnement de contexte et évitement. PMC2980623. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (fonction exécutive, prise de décision) : <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (qualitatif). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) extension. Résumé : <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia — Double empathy problem (lacunes de recherche reconnues : enfants, non-verbaux, déficience intellectuelle) : https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Note sur les niveaux de preuve : Niveau 1 = mesure directe, répliquée (MQ ; taux AuDHD) ; Niveau 2 = comorbidité répliquée avec un mécanisme partagé documenté ; Niveau 3 = extrapolation plausible, source unique ou construit contesté. Voir §5.